

Psy-CT 心理测评系统 (V1.0)

产品使用说明

一、产品概述

Psy-CT 心理测评系统是一款基于《明尼苏达多项人格问卷第二版（MMPI-2）》开发的专业人格测评工具。系统采用完整的 567 题 MMPI-2 量表结构，通过"是/否"二元作答方式，对受测者的人格特征、心理状态及临床维度进行多维度量化评估。

系统支持实时分数计算、K 校正分转换、T 分常模对照及报告单打印功能，适用于个人自我了解、人力资源评估、心理健康筛查等多种场景。

可在 <https://jyhscx114.github.io/PsyCT/> 获得该程序的最新版本。

二、MMPI 简介

2.1 什么是 MMPI

明尼苏达多项人格问卷（Minnesota Multiphasic Personality Inventory，简称 MMPI）由美国明尼苏达大学心理学家哈撒韦（S. R. Hathaway）和精神病学家麦金利（J. C. McKinley）于 20 世纪 40 年代共同编制，是迄今为止世界上使用最广泛、研究最多的人格测评工具之一。

MMPI-2（第二版）于 1989 年发布，在保留原版核心架构的基础上，更新了题目内容与常模数据，目前已成为全球临床心理学、精神病学、心理咨询、人力资源等领域的标准测评工具。

2.2 量表体系

本产品采取的 MMPI-2 量表体系包括以下几大类：

类别	说明
效度量表	评估作答有效性，识别掩饰、夸大、随机作答等情况
临床量表	10 个核心临床维度，反映主要心理病理特征
内容量表	针对特定内容领域的补充评估
附加量表	针对特定应用场景的扩展量表

三、注意事项

3.1 测试前准备

1. 环境要求：选择安静、光线充足、不受干扰的环境进行测试，确保受测者能够集中注意力。
2. 时间安排：完整测试约需 60-90 分钟，请预留充足时间，避免中途打断。
3. 状态要求：受测者应在意识清醒、情绪相对稳定的状态下作答；疲劳、醉酒或急性情绪波动时不宜测试。
4. 指导语：测试前请务必阅读以下指导原则：

- 请根据您的真实感受和实际情况作答，不要过多思考"应该怎样"
- 答案没有"对"与"错"之分，如实回答才能获得准确结果
- 每道题只能选择"是"或"否"，不要漏答
- 如对题意有疑问，可按第一印象作答

3.2 测试过程中

1. 独立作答：请受测者独立完成，他人不得提示、引导或干扰。
2. 避免极端作答倾向：不要刻意全部选"是"或全部选"否"，这样会导致测试结果无效。
3. 答题进度：系统自动保存答题进度，可随时中断并在下次继续。
4. 信息填写：请准确填写姓名、性别、年龄信息——性别选择会影响 T 分常模转换结果，是获得准确分数的必要条件。

3.3 测试后解读

- 1. 综合判断：MMPI 测试结果仅为评估参考之一，不能单独作为诊断依据，需结合专业访谈和其他评估手段综合判断。
- 2. 专业解读：测试结果建议由具备资质的心理学专业人员或精神科医师进行解读。
- 3. 避免标签化：不要仅凭某个量表分数升高就给自己或他人贴上"心理疾病"的标签。
- 4. 时效性：测试结果反映的是受测者当前状态下的心理特征，不代表永久不变的人格定型。

四、产品用途与特色

4.1 适用场景

场景	说明
个人自我了解	帮助用户了解自身人格特点、情绪状态和行为倾向，促进自我觉察与成长
心理健康筛查	用于应对企业、学校、社区等场景的心理健康状况初步筛查
人力资源评估	用于应对人才招聘、岗位匹配、团队建设中的人格特征评估
特殊情况筛查	用于应对某些对心理素质有特殊要求的部门（如军警、航空、精密操作等）

4.2 产品特点

- 1. 完整量表体系：不同于市面上多数只提供基础 10 个临床量表的简化产品，本系统涵盖效度量表、临床量表等全面分量表，能够提供更为细致和深入的测评结果，满足专业人员及特殊部门的深度评估需求。
- 2. 实时分数计算：答题过程中实时显示原始分、K 校正分和 T 分，方便了解当前答题状态。
- 3. 专业常模对照：采用 T 分标准分制，参照美国常模数据进行转换，分数具有横向可比性。

4. 报告打印功能：支持生成并打印规范格式的测评报告单，便于存档和专业解读。
5. 本地数据存储：所有答题数据保存在本地浏览器中，不上传服务器，保护用户隐私。
6. 多端适配：支持电脑、平板、手机等多种设备访问，触控与键盘操作均可。

五、分数解读说明

5.1 分数类型

本系统提供三种分数展示：

分数类型	说明
原始分 (Raw)	各分量表直接计分得到的分数，即受测者在该量表上答中题目的数量
K 校正分 (K)	部分临床量表经过 K 量表（校正量表）校正后的分数，用于修正作答态度对结果的影响
T 分 (T)	经过常模转换后的标准分数，是结果解读的主要依据

5.2 T 分解释原则

- T 分数的平均值为 50，标准差为 10
- T 分 ≥ 70 （高于平均数 2 个标准差）：提示该维度存在显著升高，可能反映相关的心理特征或症状表现，需要关注和进一步评估
- T 分 60-69：轻度升高，反映一定的倾向性
- T 分 40-59：正常范围
- T 分 < 40 ：低于常模平均水平，同样可能具有心理学意义

注：本系统参照美国常模数据进行 T 分转换。由于文化差异等因素，中国人群的测试结果解读标准可能需要适当调整。T 分 ≥ 70 的阈值标准是基于美国常模设定的，仅供参考。

六、免责声明

6.1 关于计算准确性

- 本系统的计分算法依据公开的 MMPI-2 量表计分规则编写，力求准确，但不保证 100% 的计算精确性。
- 不同版本的 MMPI 工具在计分方式、常模数据上可能存在细微差异，本系统的结果可能与其他商业版本略有出入。
- 常模转换表采用线性插值等方式实现，极端分数区间可能存在近似处理。

6.2 关于结果使用

- 本测试结果仅供参考，不能替代专业诊断。如有心理困扰或健康疑问，请咨询专业心理医师或精神科医生。
- 本系统不承担因测试结果解读或使用不当而导致的任何直接或间接责任。
- 测试结果不得作为司法、医疗等重要决策的依据。

6.3 关于常模适用性

- 本系统 T 分转换参照美国常模数据。由于文化、社会、人口学等差异，该常模标准未必完全适用于中国人群。
- 建议使用者在解读结果时考虑文化适应性因素，必要时结合本土常模或专业经验进行调整。

6.4 关于数据安全

- 本系统所有答题数据仅存储于用户本地浏览器中，不上传任何服务器。
- 请用户妥善保管自己的测试设备和数据，清除浏览器数据可能导致答题记录丢失。

七、报告单使用说明

7.1 打印与保存

- 1. 完成全部答题后（这很重要），点击"打印报告单"按钮，系统将生成规范格式的测评报告。
- 2. 报告支持直接打印或保存为 PDF 文件存档（通过浏览器打印对话框的"另存为 PDF"功能）。
- 3. 报告包含受测者基本信息、各分量表原始分/K 校正分/T 分明细、结果说明等完整内容。

7.2 报告解读路径

- 1. 自行解读：具备一定心理学知识的用户可结合本说明书的分数说明进行初步自我了解。
- 2. 专业人员解读：建议将打印的报告单交由有经验的心理咨询师、心理医师或精神科医生进行专业解读。
- 3. AI 智能分析：也可将报告数据提交给人工智能自动化分析程序进行辅助解读，但 AI 分析结果同样仅供参考。

八、操作指南

8.1 基本操作

操作	方式
回答"是"	点击"是"按钮 / 按键盘 Y 键 / 按键盘 1 键
回答"否"	点击"否"按钮 / 按键盘 N 键 / 按键盘 0 键
上一题	点击"← 上一题" / 按键盘 ← 方向键 / 右滑屏幕（移动端）
下一题	点击"下一题 →" / 按键盘 → 方向键 / 左滑屏幕（移动端）
跳至未答题	点击进度面板中的"未答题"链接
打印报告	点击"🖨️ 打印报告单"按钮

8.2 查看分数

- 左侧量表面板实时显示各分量表的原始分、K 校正分和 T 分
- T 分≥70 的项以橙色高亮显示，便于快速识别升高维度

- 答题过程中分数会实时更新，可随时查看当前状态

8.3 数据保存

- 系统自动实时保存答题进度至本地浏览器
- 关闭页面后重新打开，上次未完成的答题记录会自动恢复
- 如需清除数据重新测试，点击"重置测评"按钮即可